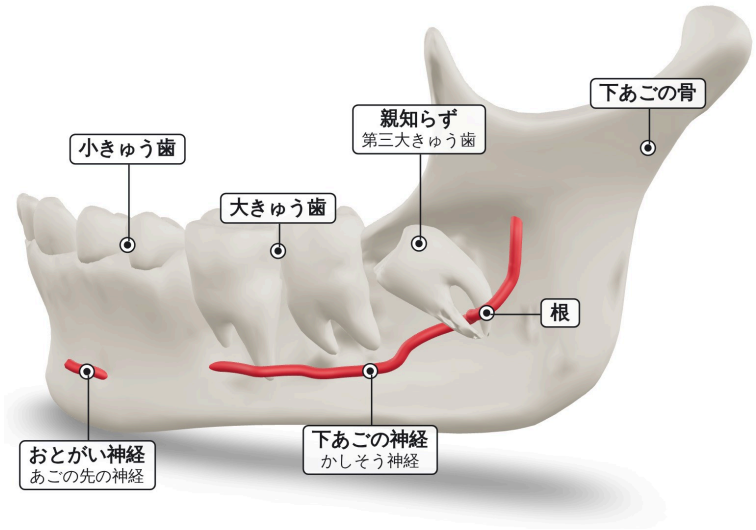
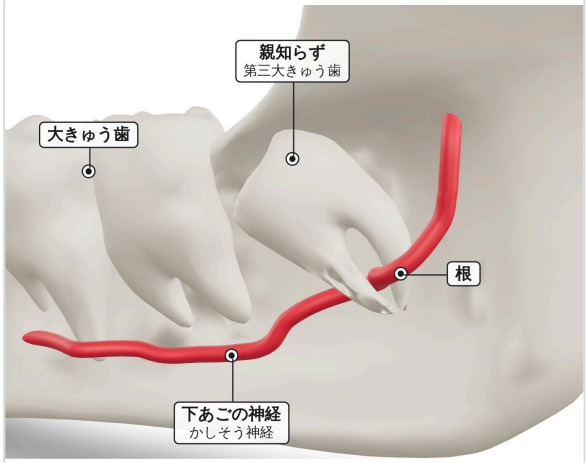
親知らずをぬくときの、神経への危険

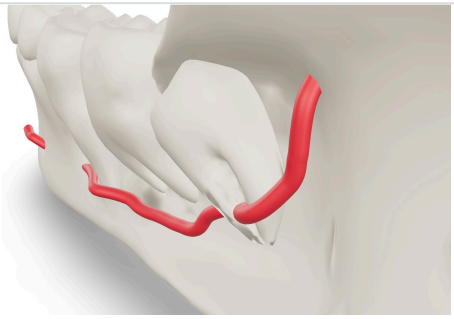
この親知らずの根は、神経に巻き付いています。歯をぬくと、神経が傷つき、くちびるやあごがしびれることがあります。



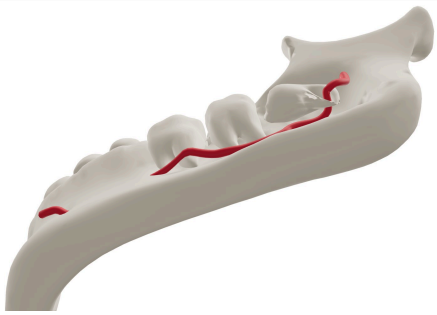
全体（ほお側）



根と神経（拡大）



後ろから見た根と神経



下から見た、骨の中の神経

どんな状態ですか？

親知らずは、いちばんおくにある歯です。「**第三大きゅう歯**」ともよびます。**うまっている下の親知らず**は、歯ぐきと骨の下にあり、歯ぐきの上に出ていません。正しい向きに生えることができません。

神経について

下あごの骨の中には、細い管があり、その中を神経が通っています。ここでは「**下あごの神経**」とよびます。医学での名前は「**かしそう神経**」です。同じ管の中を、血管（**かしそう動脈**と**かしそう静脈**）もいっしょに通っています。[1]

下あごの神経は、同じ側の下の歯と歯ぐきの感覚を伝えています。[1] あごの前の方で、この神経の枝が、骨の小さなあなから外に出ます。この枝を「**おとがい神経**」とよびます。下くちびるとあごの感覚を伝えています。[2]

親知らずをぬくと、舌の神経（**舌神経**）も傷つくことがあります。[3] 1000人に1〜3人ほどは、傷がずっと続くかもしれません。[4,5,6] このモデルでは、舌神経は表していません。

このモデルでは、**親知らずの根が、神経と動脈に巻き付いています**。

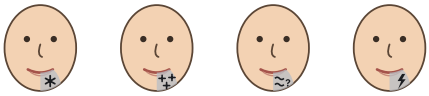
歯をぬくと、なぜ神経が傷つくことがあるのですか？

歯をぬくには、根を骨から取り出す必要があります。根は、神経を囲むように曲がっています。そのため、歯をぬくときに、神経がおされたり切れたりすることがあります。[7] いっしょに通る動脈や静脈が傷ついて、血が出ることもあります。[1,7]

下あごの神経が傷つくと、その枝のおとがい神経もうまく働かなくなることがあります。[2]

神経が傷つくと、どうなりますか？

同じ側の下くちびる、あご、歯、歯ぐきに、次のようなことが起こることがあります。[7,3]



多くの人は、数週間から数か月で感覚がもどります（**一時的**な傷）。感覚が完全にはもどらない人もいます（**ずっと続く**傷）。[7,8,9]

年れいが高い人ほど、神経が傷つきやすく、感覚も完全にはもどりにくくなります。[7,10]

どのくらい起こりますか？

根が神経に近い親知らずについて、多くの研究をまとめた報告がいくつかあります。報告によって差がありますが、次のようになります。

100人中 約7人

歯を全部ぬいた後に、神経が傷つくかもしれない[9,11,12,7]

100人中 約1人

神経の傷が治らないかもしれない[9,8,13]

このような親知らずは、口の手術を専門にする歯医者（口くう外科）にみてもらうとよいでしょう。歯の様子を調べて、どうするかをいっしょに考えてくれます。[14]

参考にした論文 **1.** Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e2. doi.org/10.5037/jomr.2010.1102 **2.** Juodzbalys G, Wang HL, Sabalys G. J Oral Maxillofac Res. 2010;1(1):e3. doi.org/10.5037/jomr.2010.1103 **3.** Renton T, Yilmaz Z. J Orofac Pain. 2011;25(4):333-344. PMID 22247929. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22247929 **4.** Lee J, Feng B, Park JS, et al. PLoS One. 2023;18(2):e0282185. doi.org/10.1371/journal.pone.0282185 **5.** Pichler JW, Beirne OR. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001;91(4):395-401. doi.org/10.1067/moe.2001.114154 **6.** Petroni G, Passaretti A, Zaccheo F, et al. Eur J Dent. 2021;15(4):776-781. doi.org/10.1055/s-0041-1730042 **7.** Sarikov R, Juodzbalys G. J Oral Maxillofac Res. 2014;5(4):e1. doi.org/10.5037/jomr.2014.5401 **8.** Kang F, Sah MK, Fei G. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2019;121(1):63-69. doi.org/10.1016/j.jormas.2019.06.010 **9.** Rico-Barroso L, Barroso-Medel M, Gutiérrez-Pérez J, et al. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2026;31(1):e19-e30. doi.org/10.4317/medoral.27459 **10.** Queral-Godoy E, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, et al. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005;99(3):259-264. doi.org/10.1016/j.tripleo.2004.06.001 **11.** Derbishi AA, Altayyar RA, Alsubaiei AS, et al. Cureus. 2026;18(3):e105646. doi.org/10.7759/cureus.105646 **12.** Kang FW, Yuan XR, Li GC, et al. J Oral Maxillofac Surg. 2025;83(5):601-615. doi.org/10.1016/j.joms.2025.01.014 **13.** Cervera-Espert J, Pérez-Martínez S, Cervera-Ballester J, et al. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016;21(4):e505-e513. doi.org/10.4317/medoral.21074 **14.** Faculty of Dental Surgery, Royal College of Surgeons of England. Parameters of care for patients undergoing mandibular third molar surgery. London: RCS England; 2020. www.rcseng.ac.uk/-/media/Files/RCS/FDS/3rd-molar-guidelines--April-2021-v3.pdf

この資料は、名古屋大学の研究のためのものです。第2.6版（2026年10月26日）。